

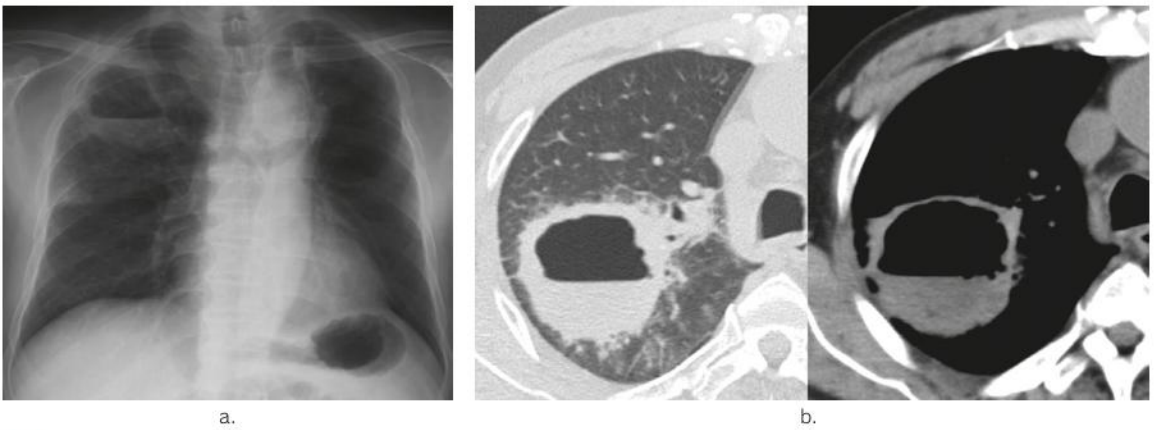


図1 肺膿瘍の画像所見 1

a: 胸部X線, b: 胸部CT

胸部X線写真において、右上～中肺野に浸潤影と air-fluid level を伴う空洞があり、CT でも壁肥厚を伴う空洞内に air-fluid level を確認できる。

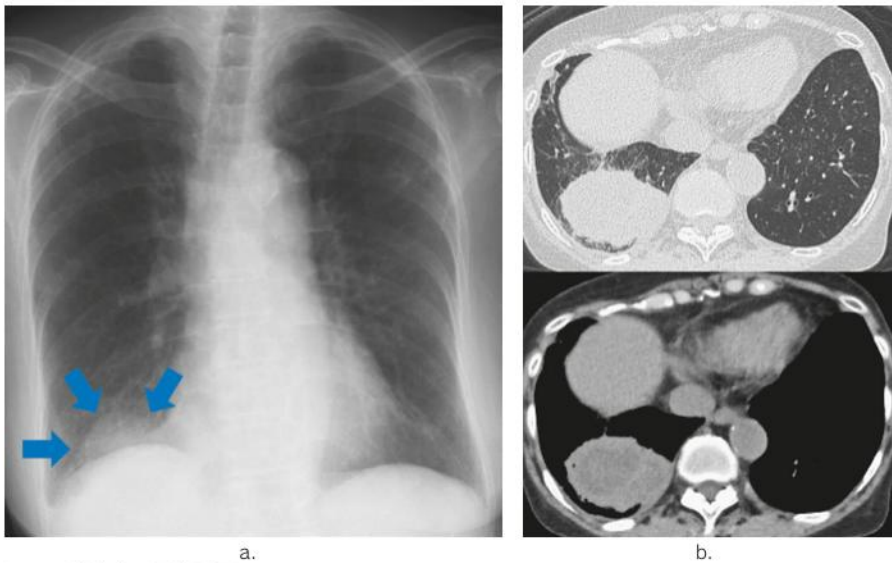


図2 肺膿瘍の画像所見 2

a: 胸部X線写真, b: 胸部CT

71 歳 女性

併存疾患：気管支拡張症、関節リウマチ

原因菌：緑膿菌

治療と予後

a 治療

i) 抗菌治療

初期治療では、表1に示した微生物を標的に考え抗菌薬を選択する。細菌性肺炎、嚥下性肺炎と類似した薬剤選択をするが、嫌気性菌にもスペクトラムを有する抗菌薬を選択することが重要である。通常、静注薬で治療を開始するが、βラクタマーゼ阻害薬配合ペニシリン（例：sulbactam/ampicillin）やカルバペネム系抗菌薬が初期治療に使用される。肺炎と同様の考

え方で薬剤低感受性菌（耐性菌）リスクが低い場合はβラクタマーゼ阻害薬配合ペニシリンを選択したほうがよい⁷⁾。免疫不全患者では、緑膿菌のリスクが上がるためカルバペネム系抗菌薬の投与は許容される。ペニシリン系抗菌薬にアレルギーがある場合の代替薬としてはキノロン薬がある。この場合、嫌気性菌にスペクトラムがあり、肺の組織移行性のよい lascufloxacin（点滴静注）が有力な選択肢である。

臨床状態が安定（発熱などの症状と画像所見が改善傾向になる）後に経口薬に変更することも可能である。この際、原因菌の薬剤感受性試験結果を参考に薬